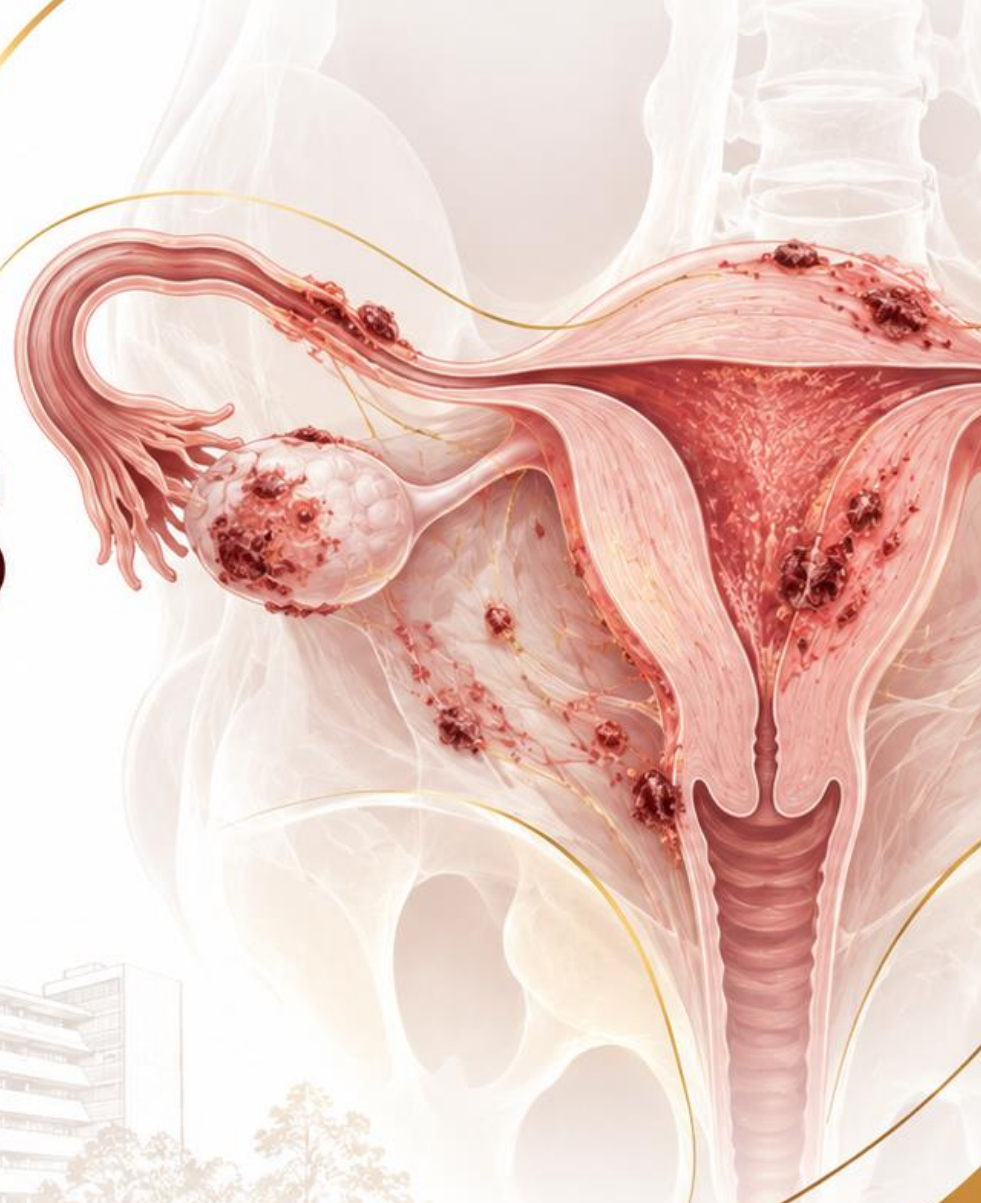
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PRODI PENDIDIKAN DOKTER

ENDOMETRIOSIS



Dr. dr. Monika F. Farid, Sp.OG, M.Kes., M.H.

Departemen Obstetri dan Ginekologi

ENDOMETRIOSIS

Standar Kompetensi Dokter Indonesia

1 SKDI 2012



- Kompetensi tingkat 2
- Kenali gambaran klinis
- Pahami diagnosis, tatalaksana & rujukan

Rujukan pembanding historis.





Pembelajaran S1

2 SKDI 2026



- Kategori kompetensi klinis baru
- Tuntas / tatalaksana awal & rujuk
- Endometriosis tidak tercantum eksplisit

Jangan langsung menyamakan dengan level lama.

3 Implikasi untuk S1

Pengenalan dini → Reasoning diagnostik → Terapi simptomatik awal → Edukasi pasien → Rujukan tepat waktu

4 Fokus Dokter Layanan Primer

- Aman
- Rasional
- Berpusat pada pasien
- Sesuai indikasi

Pesan kunci: endometriosis pada SKDI 2026 tidak ditetapkan eksplisit seperti SKDI lama; pembelajaran S1 menekankan deteksi dini, diagnosis awal, terapi aman, edukasi, dan rujukan.

Referensi utama: KKI 2026 | SKDI 2012 | ACOG 2026 | NICE NG73

CAPAIAN PEMBELAJARAN

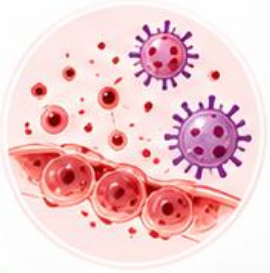
CAPAIAN UMUM | Menganalisis endometriosis sebagai penyebab nyeri panggul & gangguan reproduksi, menyusun diagnosis awal, tatalaksana awal, dan rujukan.

1 DASAR PENYAKIT

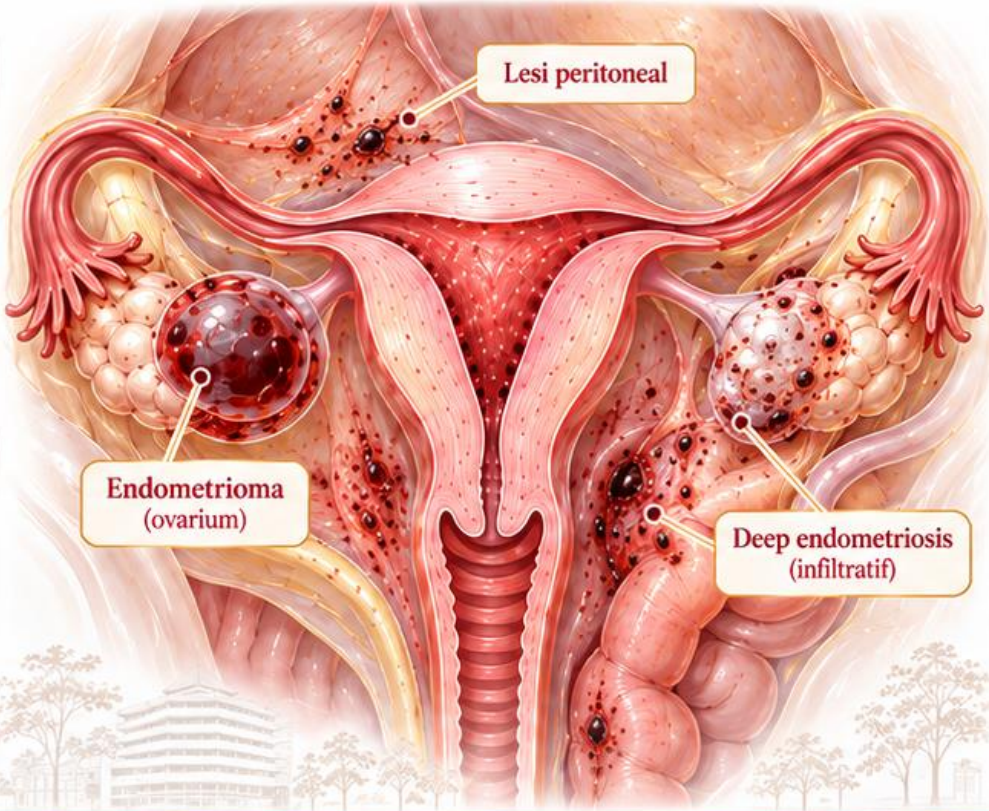


- Definisi
- Epidemiologi
- Faktor risiko

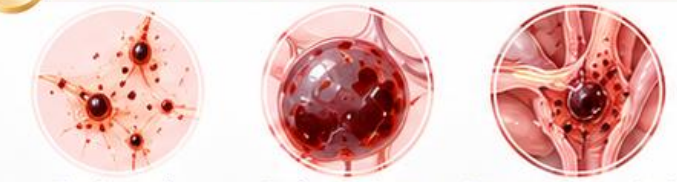
2 PATOGENESIS



- Estrogen
- Inflamasi
- Nyeri



3 FENOTIPE



Peritoneal | Endometrioma | Deep endometriosis

4 DIAGNOSIS AWAL

Anamnesis | Pemeriksaan fisik | USG | Diagnosis banding

5 TATALAKSANA & RUJUK

Analgesik | Terapi hormonal | Fertilitas | Edukasi | Rujukan

Kenali → **Analisis** → **Tata laksana awal** → **Edukasi** → **Rujuk**

OUTPUT MAHASISWA | Mampu mengenali dini, menilisi gejala, memahami terapi awal, dan menentukan indikasi rujukan.

Endometriosis
Memahami lebih dini untuk kualitas hidup yang lebih baik

Referensi utama: WHO 2025 | ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022 | KKI 2026

ENDOMETRIOSIS

Pendahuluan

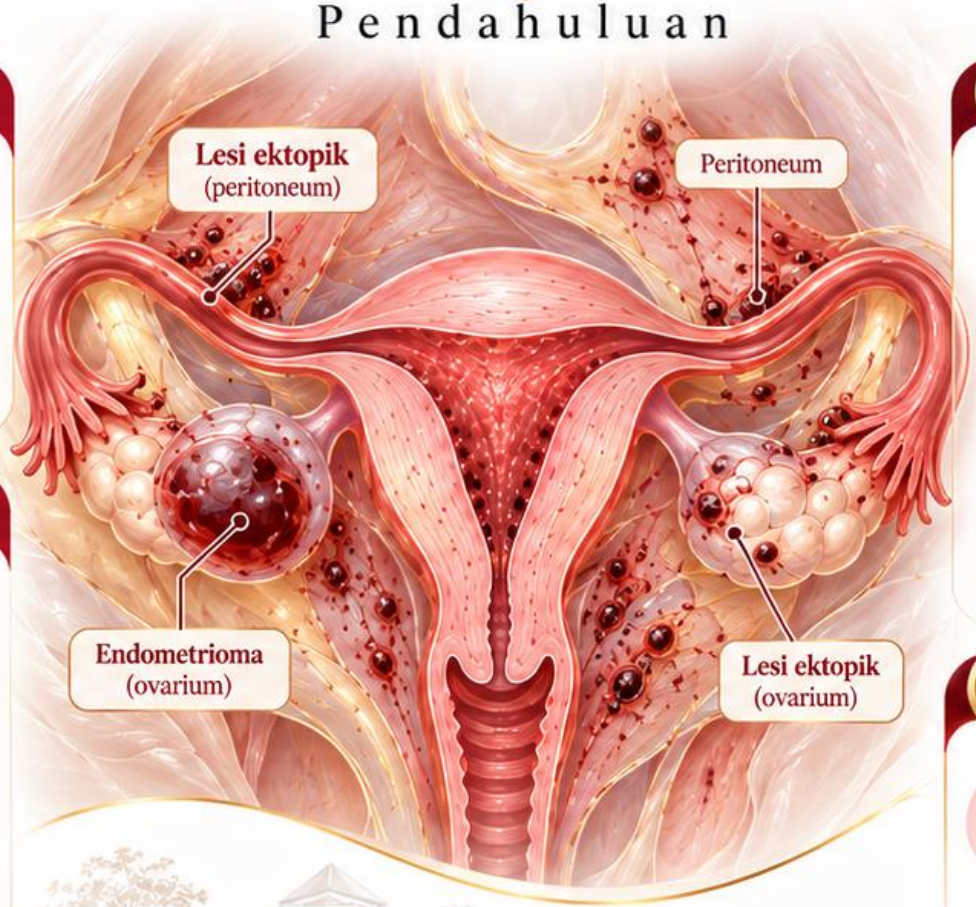
1 DEFINISI



Penyakit inflamasi kronik yang bergantung pada **estrogen**, ditandai dengan **jaringan mirip endometrium di luar kavum uteri.**

2 GEJALA UTAMA

- Dismenore
- Nyeri panggul kronis
- Dispareunia
- Infertilitas
- Gejala gastrointestinal atau urinaria



3 BEBAN PENYAKIT

±10%
perempuan usia reproduktif terdampak

190 juta
perempuan di seluruh dunia

Diagnosis sering terlambat
karena gejala tidak spesifik dan nyeri haid berat sering dianggap normal.

4 FOKUS PEMBELAJARAN

Dasar biologis → Manifestasi klinis → Anamnesis & pemeriksaan fisik → Tatalaksana awal → Rujuk sesuai indikasi

Endometriosis
Memahami lebih dini untuk kualitas hidup yang lebih baik

Referensi utama: WHO 2025 | ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022

ENDOMETRIOSIS

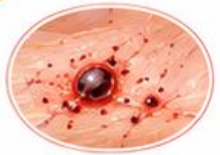
Definisi, Epidemiologi & Faktor Risiko

1 DEFINISI



- Penyakit kronis bergantung **estrogen**
- Jaringan mirip **endometrium** di luar uterus
- → inflamasi lokal

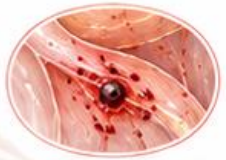
3 LOKASI UTAMA



Peritoneum



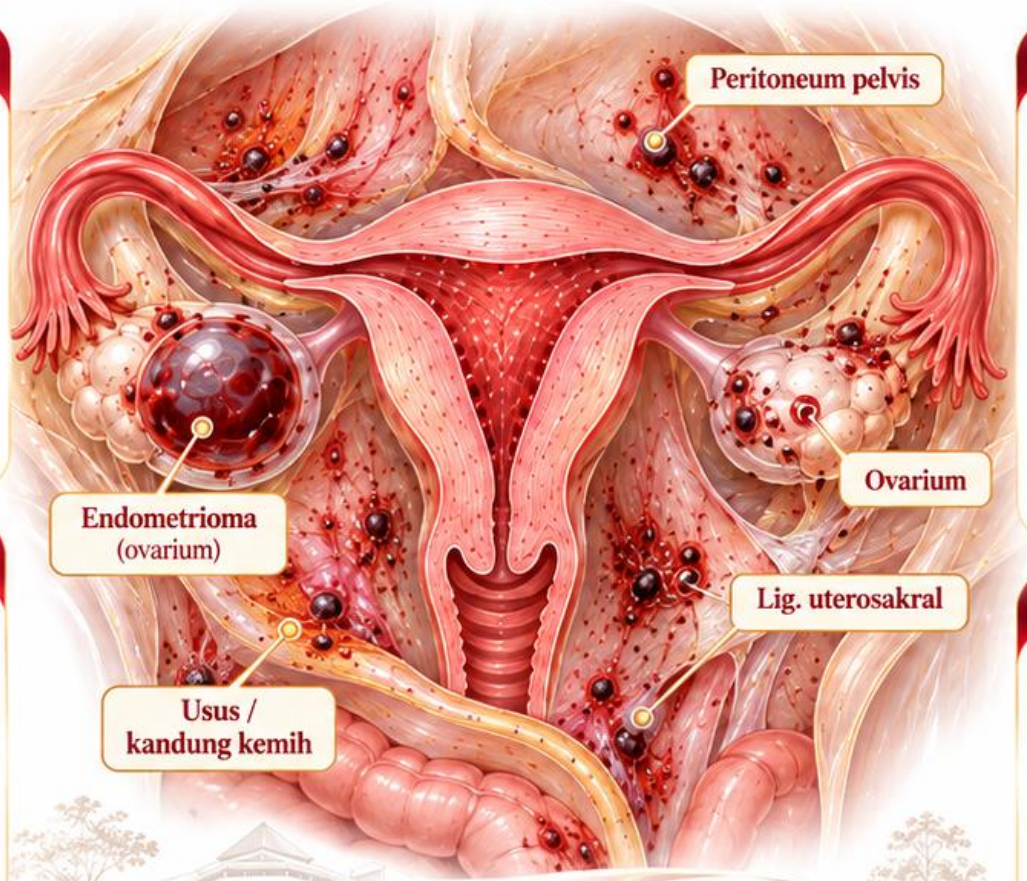
Ovarium



Lig. uterosakral



Ekstrapelvis



2 EPIDEMIOLOGI

±10%
wanita usia reproduksi

190 juta
di seluruh dunia

Dapat mulai sejak **remaja**

4 FAKTOR RISIKO

- Riwayat keluarga
- Menarke dini
- Siklus pendek
- Obstruksi aliran haid

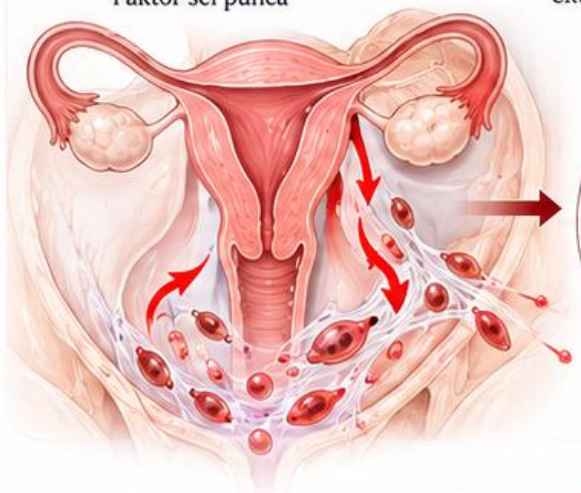
Pesan kunci: dapat terjadi sejak remaja — **tidak harus infertil**

Referensi utama: WHO 2025 | ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022

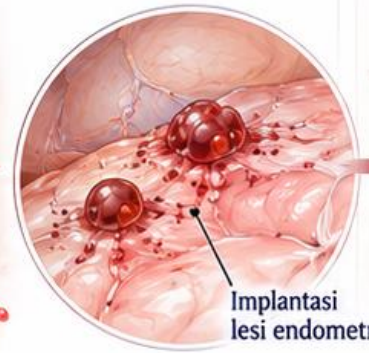
Patogenesis Endometriosis

Interaksi Hormonal, Imunologis, Genetik, dan Lingkungan

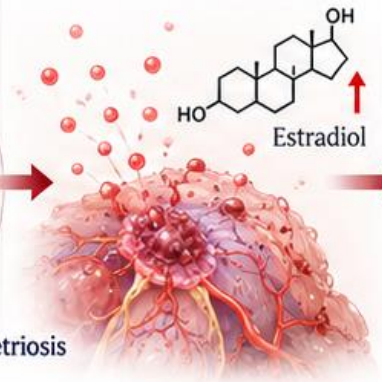
1 Menstruasi retrograd
Metaplasia selomik
Faktor sel punca



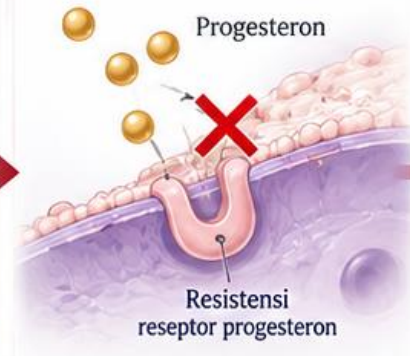
2 Implantasi & persistensi
Jaringan mirip endometrium ektopik



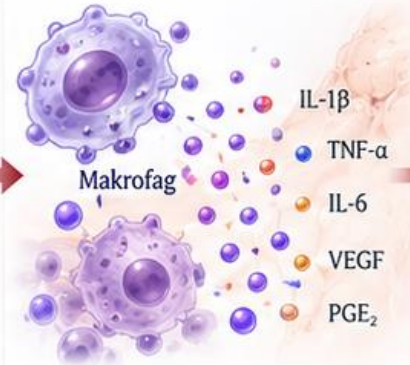
3 Estrogen lokal ↑
Pertumbuhan & kelangsungan hidup lesi



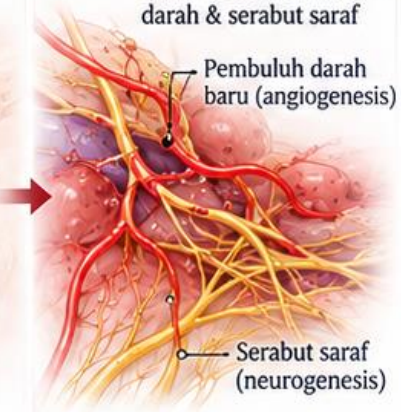
4 Resistensi progesteron
Respons antinflamasi berkurang



5 Disregulasi imun
Aktivasi makrofag & mediator inflamasi

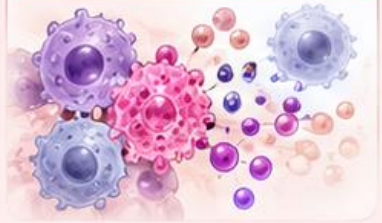


6 Angiogenesis & neurogenesis
Pertumbuhan pembuluh darah & serabut saraf

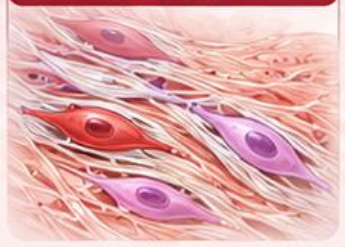


Lesi endometriosis

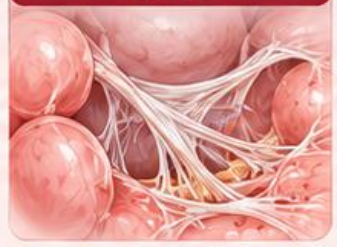
Inflamasi kronis



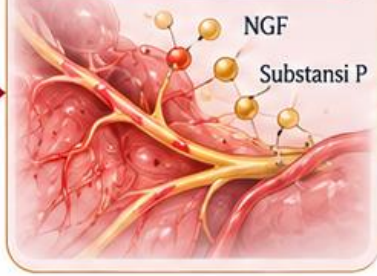
Fibrosis



Adhesi



Sensitisasi nyeri



Dampak klinis



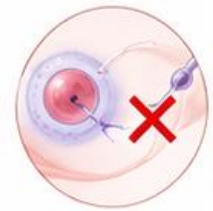
Dismenore



Nyeri panggul kronis



Dispareunia



Infertilitas

! **Teori menstruasi retrograd** menjelaskan sebagian proses, tetapi tidak dapat menjelaskan seluruh kasus.

World Health Organization | FIGO International Federation of Gynecology and Obstetrics | ACOG The American College of Obstetricians and Gynecologists | NICE National Institute for Health and Care Excellence

ENDOMETRIOSIS

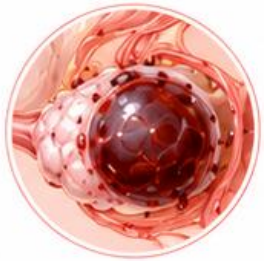
Klasifikasi & Lokasi

1 DEFINISI FENOTIPE



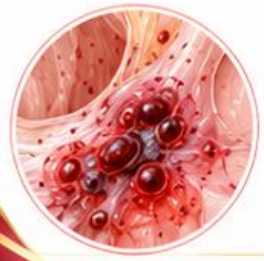
Superfisial peritoneal

Lesi dangkal pada peritoneum pelvis



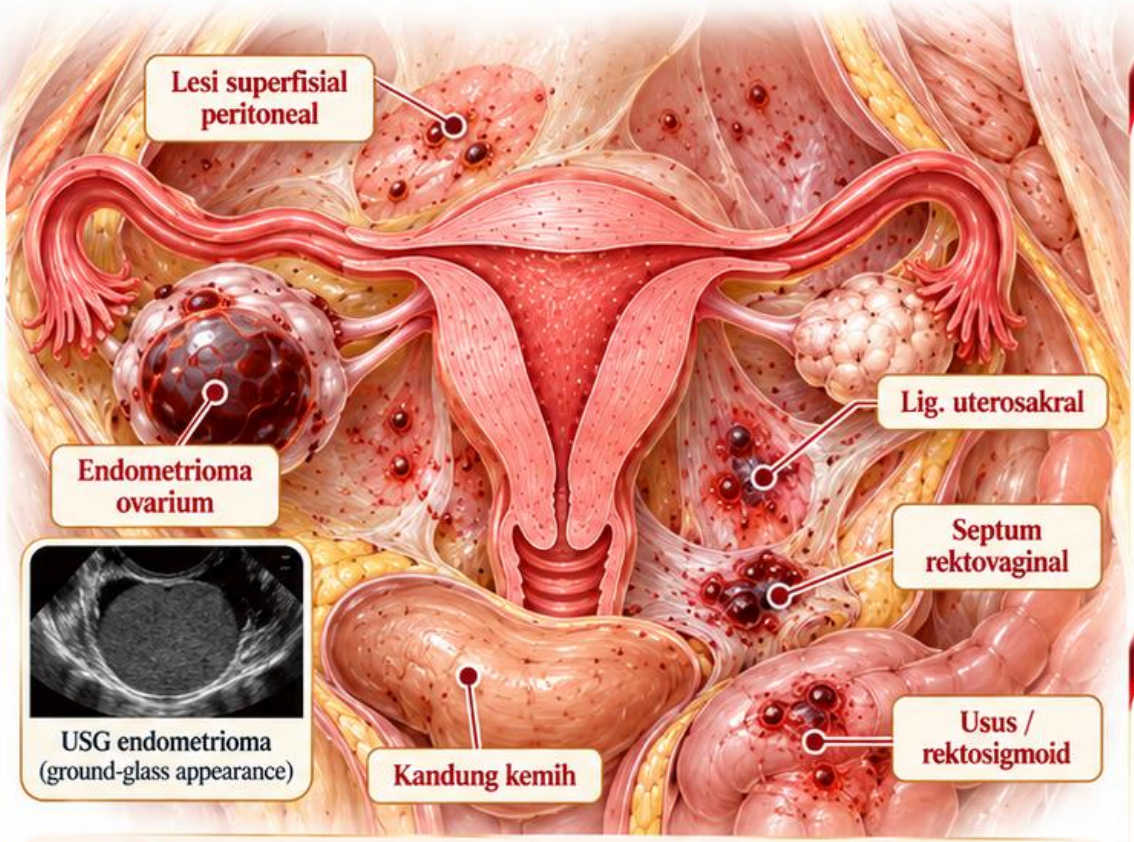
Endometrioma ovarium

Kista ovarium berisi cairan hemoragik ('chocolate cyst')



Deep endometriosis

Lesi infiltratif >5 mm di bawah permukaan peritoneum

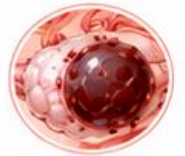


USG endometrioma (ground-glass appearance)

2 LOKASI UTAMA



Peritoneum pelvis



Ovarium



Lig. uterosakral



Septum rektovaginal



Usus / rektosigmoid



Kandung kemih / ureter

3 POIN KLINIS

- Nyeri ≠ stadium
- USG dapat normal pada lesi superfisial
- Adenomiosis ≠ endometriosis



Adenomiosis

Endometrium di **dalam** miometrium



Endometriosis

Jaringan endometrium **di luar** uterus

Pesan kunci: kenali 3 fenotipe utama dan lokasi lesi.

Referensi utama: ESHRE 2022 | ACOG 2026 | NICE NG73

ENDOMETRIOSIS

Manifestasi Klinis

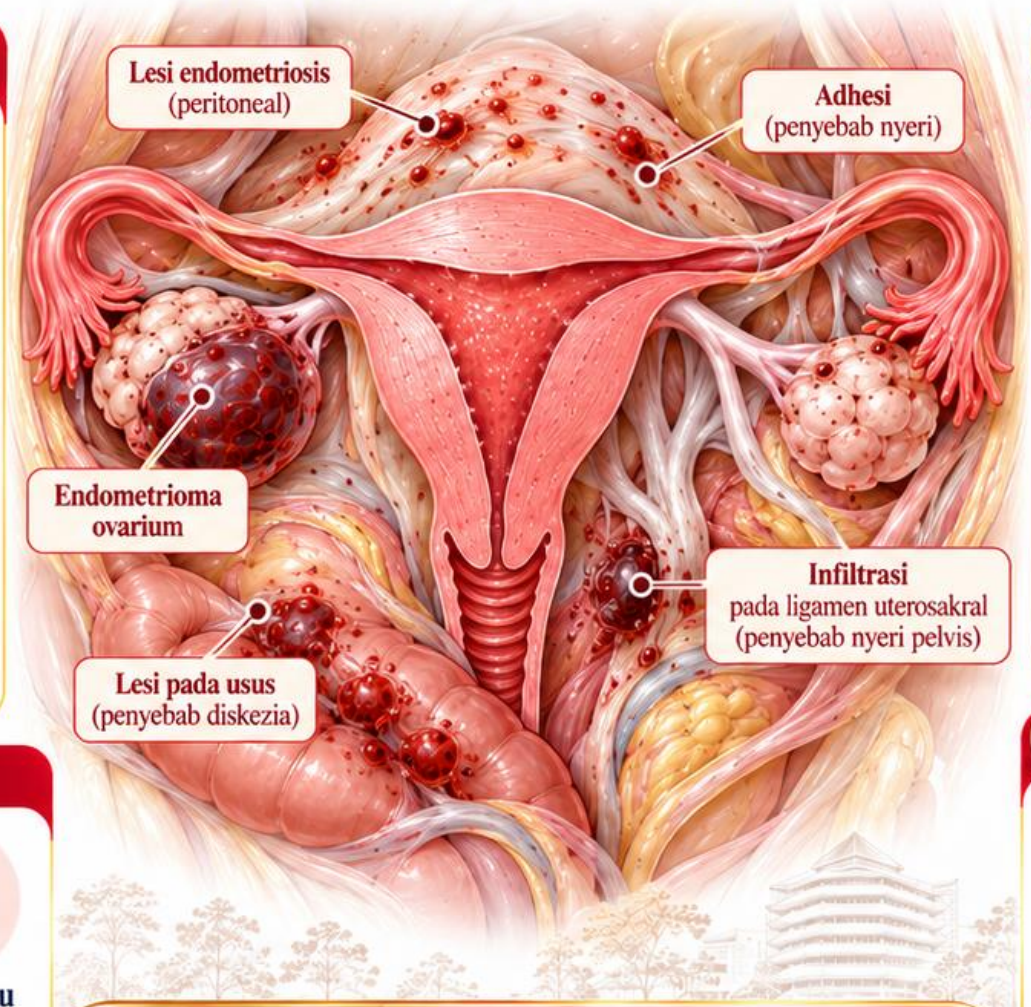
1 GEJALA NYERI

Dismenore sekunder
nyeri haid progresif

Nyeri panggul kronis
nyeri menetap/berulang

Dispareunia profunda
nyeri pelvis saat/setelah hubungan seksual

Diskezia
nyeri saat BAB, terutama saat haid



2 GEJALA TAMBAHAN

Disuria / hematuria siklik
keluhan kemih terkait siklus menstruasi

Infertilitas
sulit memperoleh kehamilan

Gangguan kualitas hidup
absen kuliah/kerja, tidur & psikologis terganggu

3 POLA KLINIS

Gejala sering kronis → Berulang sesuai siklus → Mengganggu aktivitas sehari-hari

4 RED FLAG UNTUK DICURIGAI

- Nyeri progresif
- Tidak respons analgesik biasa
- Aktivitas terganggu

Pesan kunci: dismenore berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari tidak boleh langsung dianggap fisiologis.

Referensi utama: WHO 2025 | ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022

ENDOMETRIOSIS

Pendekatan Diagnosis

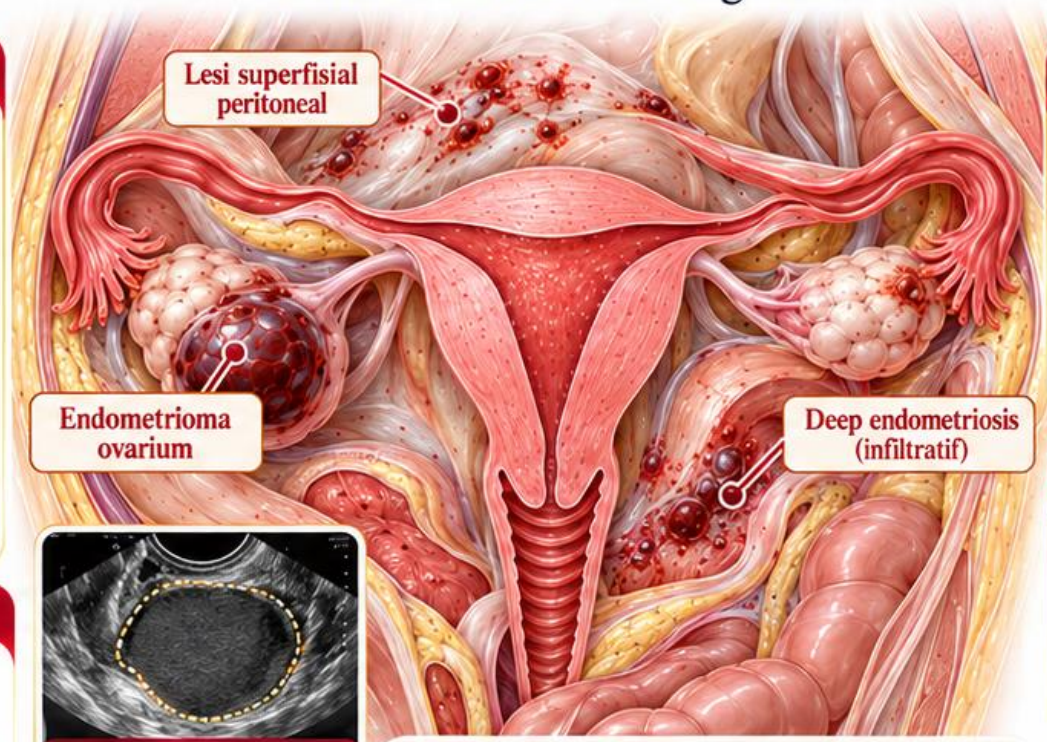
1 CURIGA KLINIS

- Nyeri haid progresif
- Nyeri panggul kronis
- Dispareunia
- Diskezia / disuria siklik
- Infertilitas

Diagnosis dimulai dari kecurigaan klinis.

2 ANAMNESIS & PEMERIKSAAN

- Pola menstruasi
- Skala & progresi nyeri
- Dampak aktivitas
- Riwayat keluarga
- Rencana kehamilan
- Abdomen & pelvis
- Nyeri tekan / massa / nodul



USG transvaginal endometrioma ovarium (ground-glass appearance)

Lokasi lesi yang sering dijumpai:

- Peritoneum pelvis (lesi superfisial)
- Ovarium (endometrioma)
- Rektovaginal / uterusakral (deep endometriosis)

3 PENCITRAAN



USG transvaginal modalitas awal



USG transabdominal alternatif



MRI pelvis pemetaan lesi dalam

USG normal ≠ menyingkirkan endometriosis.

4 PEMERIKSAAN LAIN



CA-125 bukan untuk diagnosis



Laparoskopi selektif, bukan wajib sebelum terapi empiris

Diagnosis kini dapat bersifat klinis + pencitraan noninvasif.

5 DIAGNOSIS BANDING

- Dismenore primer
- Adenomiosis
- Mioma uteri
- PID
- Kista ovarium
- IBS
- Gangguan kandung kemih

Nyeri akut: pikirkan ektopik / torsi.

Pesan kunci: diagnosis **presumtif** dapat ditegakkan secara klinis; **rujuk** bila gejala menetap atau lesi dicurigai dalam.

Referensi utama: ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022

ENDOMETRIOSIS

Prinsip Penatalaksanaan

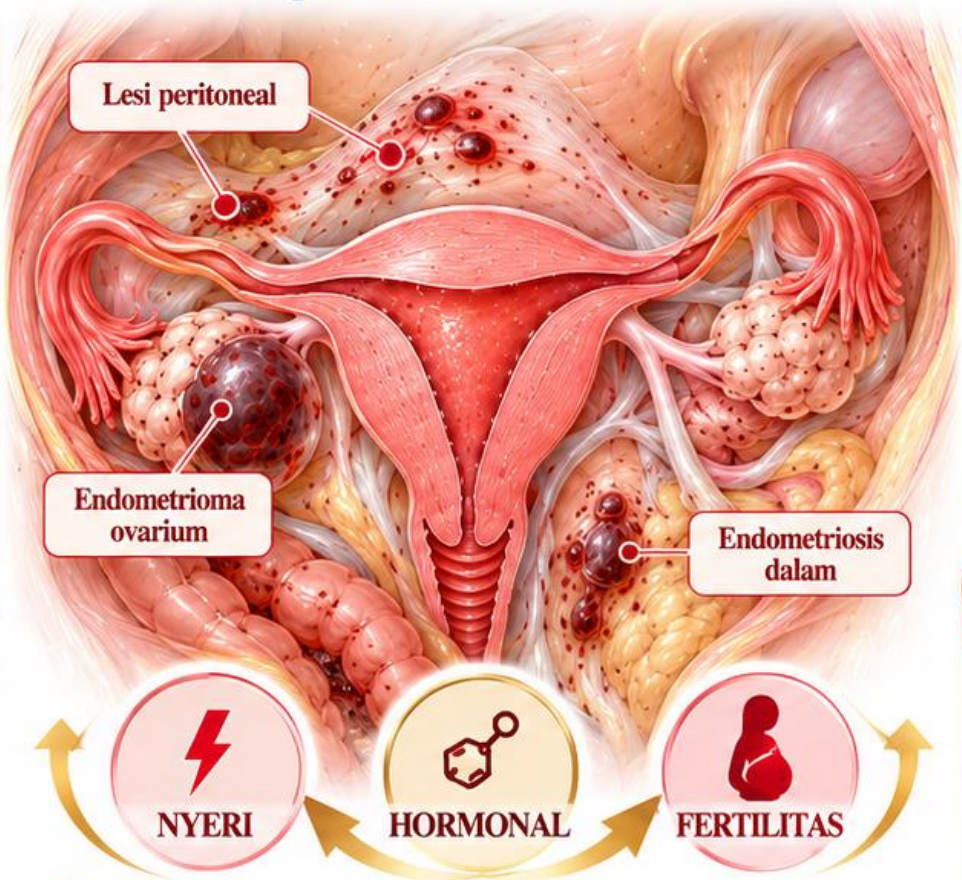
1 TUJUAN TERAPI

- Kurangi nyeri
- Perbaiki kualitas hidup
- Dukungan psikososial
- Pertimbangkan fertilitas

2 TERAPI AWAL

- Edukasi & dukungan
- NSAID / parasetamol
- Analgesik simptomatik

⚠ Sesuaikan kontraindikasi



3 TERAPI HORMONAL

- KOK
- Progestin
- LNG-IUS
- GnRH agonis/antagonis — kasus terpilih / spesialistik

! Perhatikan efek hipoestrogenik, kesehatan tulang, dan add-back therapy.

4 TINDAKAN & RUJUK

- **Laparoskopi:** gejala menetap
- Pertimbangkan lesi / fertilitas
- Rujuk bila nyeri persisten
- Rujuk bila dicurigai lesi dalam

5 PRINSIP PEMILIHAN TERAPI

Gejala → Keananan → Tujuan reproduksi → Preferensi pasien → Sumber daya

Pesan kunci: terapi tidak ditentukan hanya oleh stadium, tetapi oleh gejala, keamanan, tujuan reproduksi, dan preferensi pasien.

Referensi utama: ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022 | WHO 2025

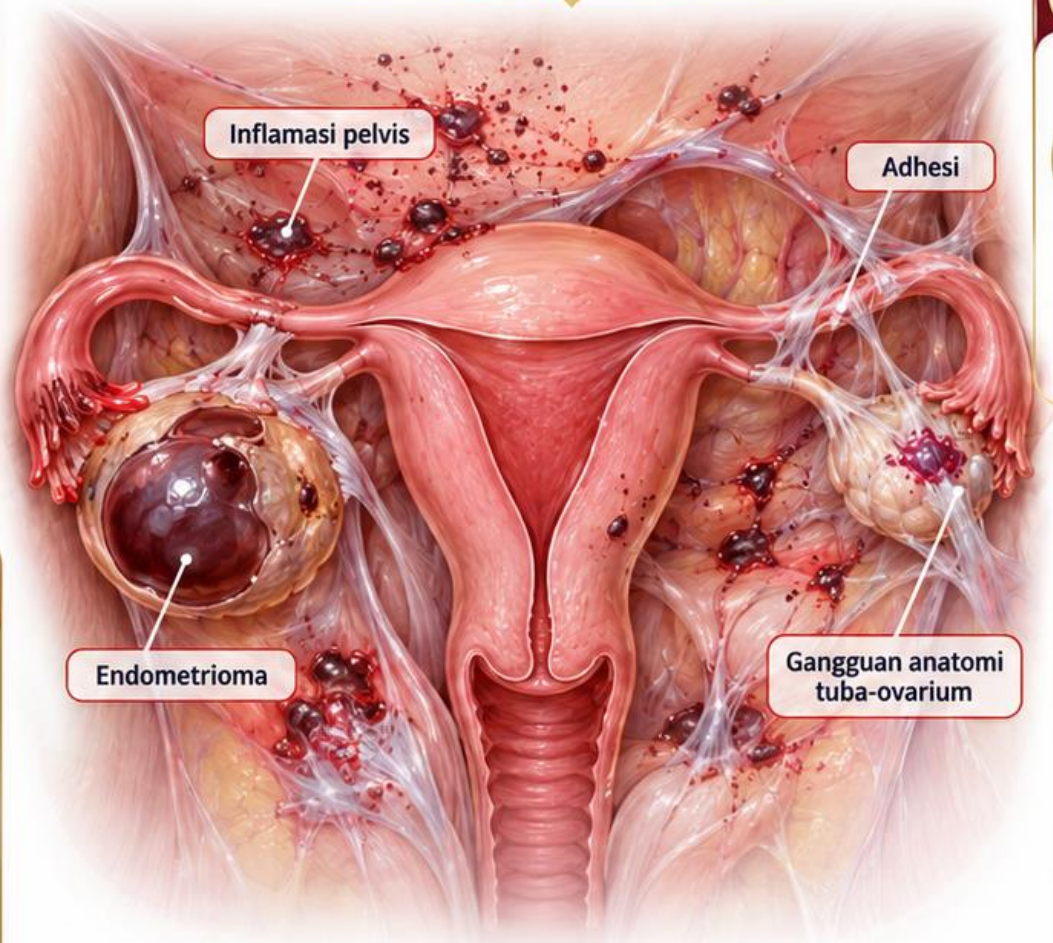
ENDOMETRIOSIS
Hubungan dengan Infertilitas

1 MEKANISME

- Inflamasi pelvis
- Adhesi
- Distorsi tuba-ovarium
- Fungsi ovarium terganggu

3 PRINSIP KLINIS

- Evaluasi infertilitas komprehensif
- Nilai faktor pasangan
- Nyeri + rencana hamil dipertimbangkan



2 DAMPAK FERTILITAS



4 PESAN TERAPI



- Supresi hormonal ≠ untuk tingkatkan hamil spontan
- Operasi endometrioma hati-hati
- Tidak semua perlu operasi sebelum ART

Pesan kunci: Endometriosis menurunkan fertilitas melalui inflamasi, adhesi, gangguan anatomi, dan fungsi ovarium; tata laksana harus menyesuaikan nyeri dan tujuan reproduksi.

ESHRE 2022 | ACOG 2026 | NICE NG73 | Oxford Academic

ENDOMETRIOSIS

Indikasi Rujukan & Edukasi Pasien

1 RUJUK ELEKTIF

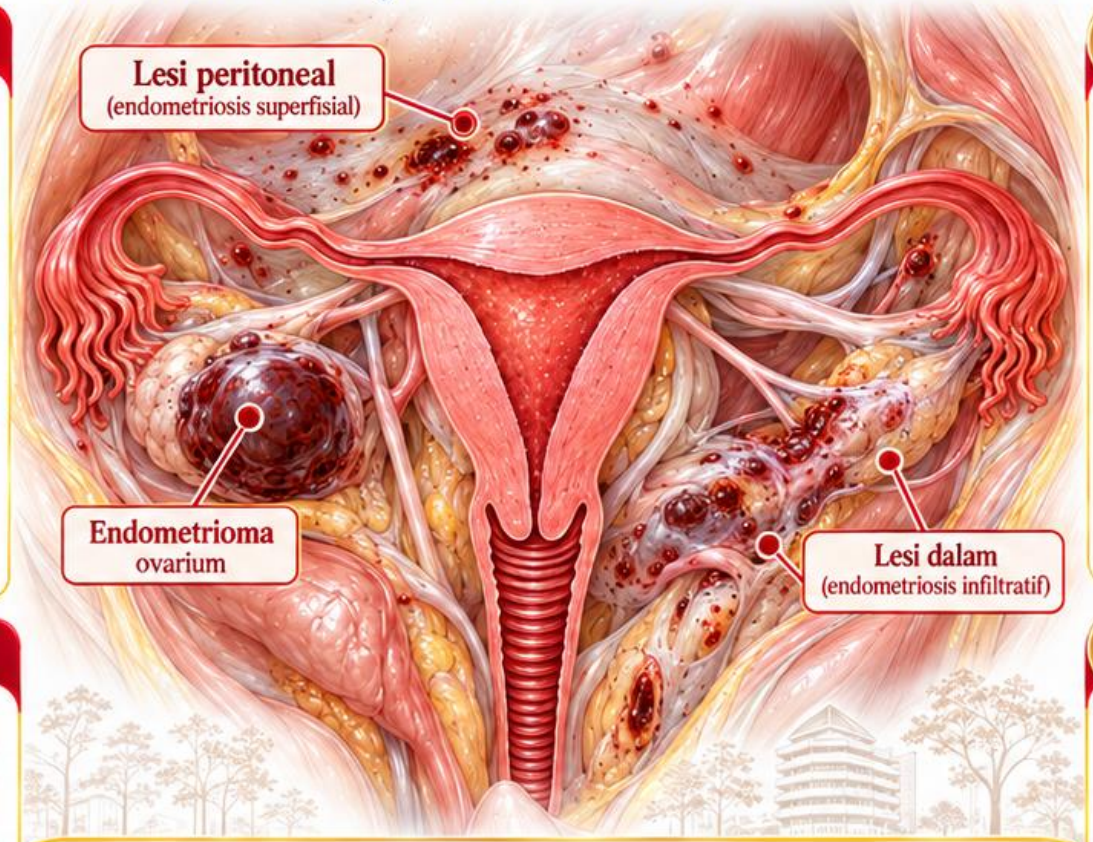
- Gejala menetap / berulang
- Aktivitas terganggu
- Respons terapi awal kurang
- Infertilitas
- Endometrioma / curiga lesi dalam

Rujuk ke Sp.OG bila evaluasi lanjut dibutuhkan.

2 RUJUK SEGERA

- Nyeri mendadak berat
- Curiga torsi ovarium
- Curiga ektopik
- Perdarahan / infeksi berat

Keadaan akut = prioritas keselamatan pasien.



3 EDUKASI PASIEN

- Penyakit kronis, dapat dikontrol
- Pilihan terapi tersedia
- Pantau gejala & aktivitas
- Diskusikan rencana hamil
- Tindak lanjut teratur

4 KOMUNIKASI KLINIS

- Empatik
- Validasi nyeri pasien
- Keputusan bersama
- Jelaskan kapan kembali

Kenali gejala → Nilai respons terapi → Edukasi → Rujuk sesuai indikasi

Pesan kunci: endometriosis memerlukan pengenalan dini, edukasi yang baik, dan rujukan tepat waktu.

Referensi utama: NICE NG73 · ACOG 2026 · ESHRE 2022

ENDOMETRIOSIS

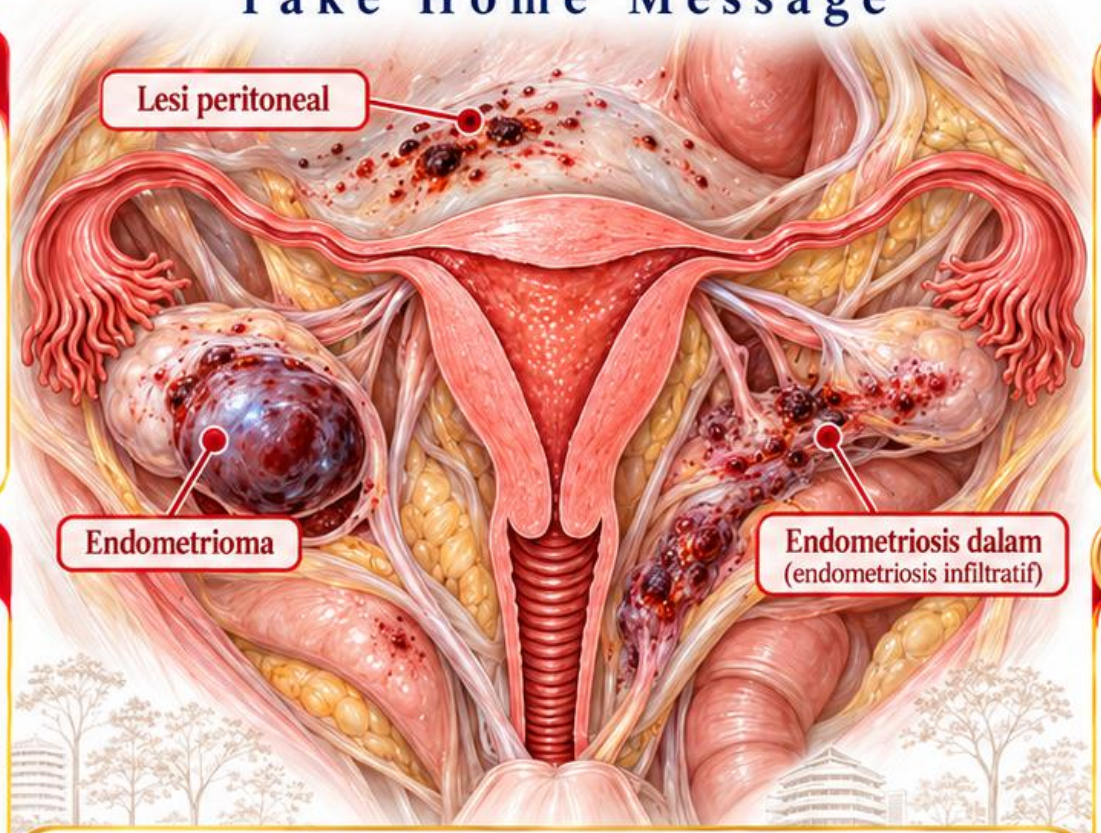
Take Home Message

1 KENALI DINI

- Nyeri haid berat & progresif
- Ganggu aktivitas = curiga endometriosis

2 DIAGNOSIS KLINIS

- Diagnosis presumtif dapat klinis
- USG normal ≠ menyingkirkan penyakit



3 TATALAKSANA PERSONAL

- Sesuaikan nyeri
- Kualitas hidup
- Fertilitas
- Preferensi pasien

4 PERAN DOKTER LAYANAN PRIMER

- Kenali lebih dini
- Terapi awal aman
- Edukasi pasien
- Rujuk tepat waktu

Curiga → Nilai → Tatalaksana awal → Edukasi → Rujuk

Pesan kunci: nyeri menstruasi berat yang mengganggu aktivitas harus menimbulkan kecurigaan endometriosis; diagnosis awal dapat bersifat klinis; tata laksana disesuaikan dengan kebutuhan pasien; dan rujukan tepat waktu sangat penting.

Referensi utama:
WHO 2025 | ACOG 2026 | NICE NG73 | ESHRE 2022

REFERENSI ENDOMETRIOSIS

1 **Standar**

KKI. 2026.
Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia No. HK.01.02/KKI/2183/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter. Ditetapkan 16 Juli 2026.

2 **Guideline**

ACOG. 2026.
Diagnosis of Endometriosis.
Clinical Practice Guideline No. 11.
Obstetrics & Gynecology. 147(3):432–448.
DOI: 10.1097/AOG.0000000000006181.

3 **Guideline**

NICE. 2017, updated 2024.
Endometriosis: Diagnosis and Management.
NICE Guideline NG73.

4 **Guideline**

Becker CM, Bokor A, Heikinheimo O, et al. 2022.
ESHRE guideline: Endometriosis.
Human Reproduction Open. 2022(2):hoac009.
DOI: 10.1093/hropen/hoac009.

5 **Fact Sheet**

WHO. 2025.
Endometriosis.
Fact Sheet. 15 October 2025.

6 **Consensus**

Society of Radiologists in Ultrasound. 2024.
Consensus on Routine Pelvic US for Endometriosis.
Radiology.
DOI: 10.1148/radiol.232191.

7 **Review**

Abike F, Tanoglu FB, Sidar G. 2025.
Deep pelvic endometriosis: clinical features, diagnosis, and treatment — a comprehensive review.
Archives of Gynecology and Obstetrics.
312:1857–1869.

Referensi utama yang digunakan dalam kuliah S1: kompetensi dokter, diagnosis, pencitraan, dan penatalaksanaan endometriosis.

KKI 2026 | ACOG 2026 | NICE NICE NG73 | ESHRE 2022 | WHO 2025

TERIMA KASIH